·理论研究·

9 种基本中医体质类型的分类及其诊断表述依据*

王 琦
(北京中医药大学 北京 100029)*

摘要:体质分类是中医体质学研究的基础与核心内容,是从复杂的体质现象中提炼出有关规律,最终建成体质分类系统。在既往体质分类研究的基础上,进一步完善了体质分类系统,将人体体质分为 9 种基本中医体质类型,并对其分类依据、命名依据、体质特征的表述原则与方法以及各体质类型的内涵和文献依据进行了阐述,旨在推动和深化中医体质学的研究。

关键词:中医体质学;体质分类研究;诊断依据
中图分类号:R 241

体质是一种客观存在的生命现象,是个体生命过程中,在先天遗传和后天获得的基础上,表现出的形态结构、生理机能以及心理状态等方面综合的、相对稳定的特质。这种特质决定着人体对某种致病因子的易感性及其病变类型的倾向性。体质的差异现象是先天因素与多种后天因素共同作用的结果。因此人类体质间的共性是相对的,而差异性则是绝对的。研究体质的分类,就必须对复杂的体质现象进行广泛的比较分析,然后甄别分类,把握个体的体质差异规律及体质特征,有效地指导临床实践。

自 20 世纪 70 年代末我们提出 7 种(正常质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、瘀血质)中医体质类型以来,得到广泛认同与应用,许多医家还从不同的角度先后提出了各自的分类方法与研究思路,不断丰富对这一问题的认识。笔者经过近 20 多年的深入研究,在完善原有分类法的基础上,结合临床观察以及古代和现代体质分类的有关认识,对原有 7 分法进行了增补,从而将中医体质分为平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、瘀血质、气郁质、特禀质等 9 种基本类型,以臻更为合理、全面地反映体质类型。

1 9 种基本中医体质类型的分类依据

《内经》是医学史上最早论述人类体质现象的重要著作,其对体质类型的划分主要有五行归属法、阴阳含量划分法、形态与机能特征分类法、心理特征分类法等方法,其分类方法是建立在对人体形态结构、生理功能和心理特征等方面观察的基础上,将人体放在自然、社会环境中去分析、归纳,主要从生理角度对体质进行分类。后世医家则在《内经》体质理论的基础上,结合临床实践对临床上常见的体质病理状态及其表现类型做了分类,如张景岳从禀赋的阴阳、脏气的强弱盛衰、饮食的好恶、用药的宜忌、气血的虚衰等方面,将体质划分为阴脏、阳脏、平脏 3 型。华岫云在叶天士《临证指南医案》中根据叶氏辨证,从形态特征、肌肉坚实与柔软及面色、面型和肤色等方面,将体质划分为阴阳 2 型。清代医家章楠以阴阳量的盛、旺、虚、弱为分类方法,将体质分为阳旺阴虚、阴阳俱盛、阴盛阳虚、阴阳两弱 4 种类型。近代医家陆晋生依据病邪的从化规律,将体质划分为湿热、燥热、寒湿、寒燥 4 种类型。清末医家金子久根据个体的形态特征、肤色及嗜好等方面的差异,将虚弱性体质划分为阳虚、阴虚 2 型等。

从《内经》及明清时期各医家对体质类型的分类方法和分类内容来看,具有以下特点。其一体现在临床应用性:从临床需要出发,以中医基础理论为指导,使体质分型与中医学的理、法、方、药密切相联,融为一体,具有很强的临床应用性。其二体现了整体性:体质类型的划分方法,贯穿了中医学"形神合一"、"天人合一"的整体观,不仅考虑了个体的形态结构特征和功能特征,而且还考虑到了个体的心理特征以及对自然、社会环境的适应性和反应性等方面的特点。这对今天的体质分类研究仍然具有重要的指导意义和参考价值。

诚然,由于受时代认识的局限,古代医家对体质

---

*王 琦,男,62 岁,教授,医学博士生导师

**国家"十五""211 工程"建设项目课题;国家重点基础研究发展计划"973 计划"项目(No. 2005CB 52350)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

类型尚未形成概念系统，难以推广应用。现代临床对体质类型的分类研究，在历代各医家对体质类型的阐述和分类的基础上有了较大发展。现代研究者对体质类型的分类所采用的大多是一种融合了《内经》、明清时期的某些分类方法的综合性方法，即采取的是以人体生命活动的物质基础——阴、阳、气、血、津液的盛、衰、虚、实变化为主的分类方法。与明清各家的体质分类内容相似，现代研究者对体质类型的划分，大多是建立在临床观察基础之上的分类方法，同样是以临床应用为目的，分类的理论依据也大都是依据人体脏腑经络、气血阴阳津液在非正常状态下的差异表现并结合中医学的病因病机理论而提出来的。目前临床对体质类型的划分，根据对王琦、匡调元、母国成、何裕民、秦德平、杨常青、赵志付、庞万敏、林齐鸣、和嘉芳等 10 位专家论著中对体质分类的表述，发现常见的类型主要有：正常质(阴阳平和质)、阴虚质、阳虚质、痰湿质、瘀血质、阳盛质、气虚质、气滞血瘀质、阴盛质、气血两虚质、湿热质、阴阳两虚质、血虚质、气滞质等 14 类。其中，各种体质类型出现的频次分别是：正常质 9 次，阴虚质 10 次，阳虚质 10 次，阴盛质 4 次，阳盛质 6 次，阴阳两虚质 3 次，气虚质 5 次，气郁质 2 次，血虚质 3 次，瘀血质 8 次，气血两虚质 4 次，痰湿质 9 次，湿热质 5 次，气滞血瘀质 5 次。由上述数据可知，各体质类型在 10 位学者体质分型方法中出现频率达 5 次以上的有正常质、阴虚质、阳虚质、阳盛质、气虚质、气滞血瘀质、瘀血质、痰湿质、湿热质，呈现相同趋向。

我们继承了古代及现代体质分型方法的临床应用性原则以及现代学者以阴、阳、气、血、津液的盛、衰、虚、实变化为主的分类方法，在原来体质 7 分法的基础上，结合临床实践，提出了体质 9 分法，即在上述出现频率较多的体质类型中保留了正常质(平和质)、阴虚质、阳虚质、气虚质、瘀血质、痰湿质、湿热质，去掉了阳盛质、气滞血瘀质，增加了气郁质、特禀质。原因有以下几点：①按阴阳平衡的理论有阴虚质就应该有阳盛质，实际上也存在阳盛体质，但这种体质对健康并没有什么影响，故未被列为基本体质类型。②气滞血瘀质可以作为瘀血质和气郁质的兼夹体质，故也未被列为基本体质类型。③增加了气郁质。古人已经认识到这一体质类型的存在，加之现代社会竞争激烈、生活压力大，许多人存在心理障碍，临床上经常可见气郁体质之人，这种体质又容易导致诸多心身疾病，所以增加了气郁质。④特禀质这一体质类型虽然古代及现代中医学者并没有提出，但已有禀赋遗传的认识。这一体质类型确实常见，如过敏体质就属于特禀质，中医药改善过敏体质有较好的效果，本着临床实用性的原则出发，增加了特禀质。将人体体质划分为 9 种基本体质类型，以臻更为合理、全面地反映体质类型，有效地指导临床实践。

2 9 种基本中医体质类型的命名依据

体质命名应朝着规范化的方向发展，目前体质命名多有不一，如阴虚质又称“盗热质”、“燥红质”等。根据专家论证比较一致的看法是，中医体质分类命名应与中医学基本名词保持一致，使之在理论内涵上相互贯通，便于临床应用，并避免一名多义。目前临床对体质类型的命名多数都按照阴、阳、气、血、津液的偏颇失衡为命名原则，如阴虚质、阳虚质、阳盛质、气虚质、瘀血质、痰湿质、湿热质、气郁质等。本文所列 9 种体质分类的命名，即采取的是以人体生命活动的物质基础——阴、阳、气、血、津液的偏颇失衡为主的分类方法。分类命名的理论依据也大都是依据人体脏腑经络、气血阴阳津液在非正常状态下的差异表现并结合中医学的病因病机理论而提出来的，便于理解和应用。

3 9 种基本中医体质类型特征表述的原则与方法

3.1 9 种基本中医体质类型特征表述的原则

①体质特征的表述必须符合体质的定义，即从形体特征、生理特征、心理特征、病理反应状态、发病倾向等方面反映体质特征。②以体质医学的临床应用性、实践性为原则，从指导临床和疾病的诊断、辨证、治疗的目的出发，为个体化诊疗和临床医学的发展，提供理论、方法和途径。

3.2 9 种基本中医体质类型特征表述的方法

①表述内容。按照定义、体质特征、成因进行体质类型表述，其特征表述以形体特征、常见表现、心理特征、发病倾向、对外界环境适应能力 5 个方面进行。其中常见表现主要从面色、眼目、口鼻、精神状态、饮食、二便、舌脉等方面的特征进行表述。为了体现不同特征对体质诊断的贡献度，我们利用统计方法将特征分为主项和副项。②表述的文献依据。根据古代文献检索和现代文献体质分类及特征表述的数据统计进行表述。为了客观地对体质分类及特征进行表述，共检索了《内经》至民国期间重要古代文献 108 种及现代文献 60 余种。其中，古代文献按照命名、体质特征、发病倾向、形成因素 4 个方面对有关体质的内容进行全面检索。现代文献按照其记录的体质分类及特征表琐的统计分析，对 11 位现代

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

中医体质研究学者有关体质分类及特征的表述[1~7]进行了出现频率的统计。其中，古代文献计 109 个体质特征描述，现代文献计 408 个特征描述，以此作为体质分类及特征表述的参考。③表述的流调依据：近代医家[8~14]分别进行了 1 000 例以上样本的流行病学调查，流调总数达 12 471 例。

4　9 种基本中医体质类型的内涵与分类依据

4.1　平和质

4.1.1　内涵

(1) 定义。强健壮实的体质状态，表现为体态适中，面色红润，精力充沛状态。

(2) 体质特征。①形体特征：体形匀称健壮。②常见表现：面色、肤色润泽，头发稠密有光泽，目光有神，鼻色明润，嗅觉通利，口和，唇色红润，不易疲劳，精力充沛，耐受寒热，睡眠良好，胃纳佳，二便正常，舌色淡红，苔薄白，脉和有神。③心理特征：性格随和开朗。④发病倾向：平素患病较少。⑤对外界环境适应能力：对自然环境和社会环境适应能力较强。

(3) 成因。先天禀赋良好，后天调养得当。

4.1.2　文献依据

(1) 古代文献依据。①命名依据。《内经》中称“阴阳和平之人”、“平人”。②特征表述依据。《素问·调经论》曰：“夫阳与阴，皆有俞会。……阴阳匀平，以充其形，九候若一，命曰平人。”《灵枢·天年》曰：“五脏坚固，血脉和调，肌肉解利，皮肤致密，营卫之行，不失其常，呼吸微徐，气以广行，六府化谷，津液布扬，各如其常，故能长久。”③形成因素依据。《灵枢·通天》云：“阴阳和平之人，其阴阳之气和，血脉调。”

(2) 现代文献依据(每一项特征后面的数字表示该特征出现的频率，下同)。肥瘦匀称、健壮 5；精力充沛 3；发盛长色黑 2；毛发润泽 1；面色红润 4；面色润泽 4；面色红黄隐隐，明润含蓄 2；有些人稍白、稍黑为个体特征差异 1；目光有神 2；精采内含 2；鼻色明润，嗅觉通利 2；口和，唇红润 2；轻劲有力，耐受寒热 4；性格多平和，开朗 2；气质从容大度，无惧无欣，尊重谦谨，行缓心安，喜怒有节 1；胃纳佳 5；大小便正常，舌质淡红、润泽、披薄苔，脉象从容和缓，节律一致 3；多患外感暴病，证多实热 2；多见于青春期健康者 2；平素少病，得病多为外感实热证 1；对四时寒暑燥湿及多种地理环境能适应或能耐受 1；身心舒畅，抗病力强，病变无特殊 1。

4.2　气虚质

4.2.1　内涵

(1) 定义。由于元气不足，以气息低弱、机体、脏腑功能状态低下为主要特征的一种体质状态。

(2) 体质特征。①形体特征：肌肉不健壮。②常见表现：主项：平素语音低怯，气短懒言，肢体容易疲乏，精神不振，易出汗，舌淡红，舌体胖大、边有齿痕，脉象虚缓。副项：面色偏黄或㿠白，目光少神，口淡，唇色少华，毛发不华，头晕，健忘，大便正常，或有便秘但不结硬，或大便不成形，便后仍觉未尽，小便正常或偏多。③心理特征：性格内向、情绪不稳定、胆小不喜欢冒险。④发病倾向：平素体质虚弱，卫表不固易患感冒；或病后抗病能力弱易迁延不愈；易患内脏下垂、虚劳等病。⑤对外界环境适应能力：不耐受寒邪、风邪、暑邪。

(3) 成因。先天本弱，后天失养或病后气亏。如家族成员多数较弱、孕育时父母体弱、早产、人工喂养不当、偏食、厌食，或因年老气衰等。

4.2.2　文献依据

(1) 古代文献依据。①命名依据。古人多称“气弱”、“气衰”、“气虚之人”，《灵枢·寿夭刚柔》云：“形有缓急，气有盛衰，骨有大小，肉有坚脆，皮有厚薄，……形充而脉小以弱者气衰。”②特征表述依据。明·张景岳《景岳全书·杂证谟》云：“何以肥人多气虚，盖人之形体，骨为君，且肉以血成，总属阴类，故肥人多有气虚之证。”清·石寿棠《医原》曰：“诊其人之病，须先辨其人，气质阴阳，金水之质，其人肥白，多属气虚。”③发病倾向依据。《灵枢·论勇》称“薄皮弱肉”之瘦弱之人易于感触风邪，清·陈梦雷《医部全录》注云：“薄皮弱肉，则赃真气虚矣。”《灵枢·逆顺肥瘦》篇：“……瘦人者，皮薄肉少，肉廉廉然，薄君轻言，其血清气滑，易于脱气，易损于血。”清·吴德汉《医理辑要》中云：“易风为病者，表气素虚”、“易劳伤者，中气必损”。④形成因素依据。宋·万全《幼科发挥》云：“子于父母，一体而分，如受肺之气为皮毛，肺气不足，则皮脆薄怯寒，毛发不生；受心之气为血脉，心气不足，则血不华色，面无光彩；受脾之气为肉，脾之气不足，则肌肉不生，手足如削；受肝之气为筋，肝之气不足，则骨软。”论述了禀赋对气虚体质的影响。

(2) 现代文献依据。体形胖瘦均有，瘦人为多 2；毛发不华 2；面色偏黄或㿠白 7；肤色黄 1；目光少神 3；目胞睑淡白；唇口淡白，齿易松劲 1；鼻色淡黄，口淡，唇色少华 1；气短懒言 5；眩晕 3；心悸健忘，动辄出汗 2；自汗出 4；肢体容易疲乏 7；手易麻 2；有内脏下垂 3；寒热耐受力差、尤不耐寒 3；不耐劳累 1；心悸失眠 3；腰膝酸软 1；男子滑精早泄，女子白带清稀 1；神情偏淡漠，性格或偏软弱 1；性格一般喜静 2；食

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

减不化、或喜食甜食 2;食欲不振 2;大便正常或有便秘、但不干结、或大便不成形、便后仍觉未尽,小便正常或偏多 2;小便频多 1;舌淡红、边有齿痕 2;脉象虚缓 1;舌淡苔白,脉象虚弱 1;舌质正常或偏淡,脉象正常或偏弱 1;舌淡而嫩,脉象细弱 1;易患外感,有气虚诸病史 2。

4.3 阳虚质

4.3.1 内涵

(1) 定义。由于阳气不足、以虚寒现象为主要特征的体质状态。

(2) 体质特征。①形体特征:多形体白胖,肌肉不壮。②常见表现:主项:平素畏冷,手足不温,喜热饮食,精神不振,睡眠偏多,舌淡胖嫩边有齿痕、苔润,脉象沉迟而弱。副项:面色柔白,目胞晦暗,口唇色淡,毛发易落,易出汗,大便溏薄,小便清长。③心理特征:性格多沉静、内向。④发病倾向:发病多为寒证,或易从寒化,易病痰饮、肿胀、泄泻、阳痿。⑤对外界环境适应能力:不耐受寒邪、耐夏不耐冬;易感湿邪。

(3) 成因。先天不足,或病后阳亏。如家族中均有虚寒表现,孕育时父母体弱、或年长受孕,早产,或平素偏嗜寒凉损伤阳气,或久病阳亏,或年老阳衰等。

4.3.2 文献依据

(1) 古代文献依据。①命名依据。清·叶天士《临证指南医案》:"形躯丰溢,脉来微小,乃阳气不足体质",清·章楠《医门棒喝》:"此阴盛阳虚之质",《金子久专辑》则明确提出:"体胖丰腴,肌肤柔白,阳虚禀质显然。"②特征表述依据。《素问·逆调论》云:"阳气少,阴气多,故身寒如从水中出。"《素问·调经论》云:"阳虚则外寒……阴盛则内寒。"《景岳全书》:"禀有阴阳,则以阴脏喜温暖而宜姜桂之辛热。"《医学心悟》:"阴脏者阳必虚,阳虚者多寒。"③发病倾向依据。《外感温热篇》:"如面色白者,须要顾其阳气,湿甚则阳微也。"《临证指南医案》:"大凡六气伤人,因人而化……阳虚者湿甚,邪伤气分为多。"《医理辑要》:"易寒为病者,阳气素虚。"陆平一《丹溪医论选》:"人之生也,体质各有所偏……偏于阳虚,脏腑寒湿,易感湿症。"清·柯琴《伤寒来苏集》:"若其人阳气素虚者,因熏灼而喘。"宋·庞安时《伤寒总病论》:"凡人禀气各有盛衰,……假令有寒者,多病阳衰阴盛之疾,或病阴毒也。"清·章楠《医门棒喝》在探讨暑病源流时指出:"人身阳气旺,邪随火化而阳暑病;人身阳气虚,邪随湿化而阴暑病。"④形成因素依据。虚寒体质形成有禀赋因素和饮食因素,明·张景岳在《景岳全书》中指出:"禀赋素弱多有阳衰阴盛者,此先天阳气不足也";"生冷内伤,以致脏腑多寒";"素禀阳脏,每多恃强为食生冷茶水而变阳为阴"。

(2) 现代文献依据。形体白胖 4;偏瘦弱或虚胖 1;毛发易落 3;面色㿠白 5;清澈貌或目胞晦暗 2;鼻头冷,色膏 2;口唇色淡 3;声音偏低微,呼吸偏短而凉 1;耳鸣聋 2;手足发凉 5;不耐寒凉 4;肢冷自汗 1;身目虚浮 2;腹痛喜暖喜按 1;多蜷曲怠惰 1;孤独喜静,深谋不露,谨慎柔弱,深思多虑 1;多沉静庄重,情感内向,对外界事物冷漠回避 1;胃纳一般食少多喜热烫饮食 1;饮食睡眠一般或偏多眠 1;喜热饮食 4;大便溏薄,小便清 4;夜尿清长 2;夜尿较多 1;舌淡胖嫩 4;苔白润 3;脉象沉迟而弱 3;发病外寒较甚,易从寒化伤阳 2。

4.4 阴虚质

4.4.1 内涵

(1) 定义。由于体内津液精血等阴液亏少,以阴虚内热为主要特征的体质状态。

(2) 体质特征。①形体特征:体形瘦长。②常见表现:主项:手足心热,平素易口燥咽干,鼻微干,口渴喜冷饮,大便干燥,舌红少津少苔。副项:面色潮红、有烘热感,目干涩,视物花,唇红微干,皮肤偏干、易生皱纹,眩晕耳鸣,睡眠差,小便短涩,脉象细弦或数。③心理特征:性情急躁,外向好动,活泼。④发病倾向:平素易患有阴亏燥热的病变,或病后易表现为阴亏症状。⑤对外界环境适应能力:平素不耐热邪,耐冬不耐夏;不耐受燥邪。

(3) 成因。先天不足,或久病失血,纵欲耗精,积劳伤阴。如家族成员体形多偏瘦,孕育时父母体弱、或年长受孕,早产,或曾患出血性疾病等。

4.4.2 文献依据

(1) 古代文献依据。①命名依据。《医门棒喝》:"此阳旺阴虚之质也,每病多火,须用滋阴清火。"②特征表述依据。《素问·调经论》云:"阴虚则内热",元·朱丹溪《格致余论》:"瘦人火多",《医学心悟》:"阳旺者阴必虚,阴虚者多火",《临证指南医案》:"瘦人阴不足",《医门棒喝》:"面苍阴虚之人,其形瘦者,内火易动。"《金子久专辑》:"形瘦尖长,皮色憔悴,阴虚木火无疑。"③发病倾向依据。《伤寒总病论》:"凡人禀气各有盛衰,……素有热者,多病阳盛阴虚之候,或病阳毒也。"《医理辑要》:"易热为病者,阴气素虚。"《临证指南医案》:"大凡六气伤人,因人而化,阴虚火旺,归营分多。"《伤寒来苏集》:"若其人

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

阳气素盛者，因熏灼而伤阴血。”④形成因素依据。《丹溪医论选》：“人之生也，体质各有所偏……偏于阴虚，脏腑燥热，易感温病。”

(2) 现代文献依据：体形瘦长 5；面色潮红 2；有烘热感 2；面色萎黄或白皙，指甲或唇色淡白 2；巩膜红丝 2；目干涩 2；视物花 3；目眵多 2；鼻微干，口燥咽干，唇红微干 2；声音偏嘶哑，呼吸偏气热 1；畏热，手足心热 4；眠心烦，五心烦热 3；耳鸣聋 3；常有烦热之感或易头晕 2；精神充沛 1；失眠心悸 1；多怕，少热而恶燥，对寒温带气象较适宜，而对热带气象不易适宜 2；神情偏烦躁 1；好动易变，活泼乐观 1；多急躁易怒而好强 1；急躁易怒 2；胃纳一般 1；喜冷饮而不解渴 3；大便干燥 5；小便短涩 2；尿黄短少 2；质红少苔 5；或无苔，或见龟裂 1；脉象细弦或数 3；禀赋弱，或久病失血，纵欲伤精积劳，易化热伤阴，动火生风 2。

4.5　痰湿质

4.5.1　内涵

(1) 定义。由于水液内停而痰湿凝聚，以粘滞重浊为主要特征的体质状态。

(2) 体质特征。①形体特征：体形肥胖、腹部肥满松软。②常见表现：主项：面部皮肤油脂较多，多汗且粘，胸闷，痰多。副项：面色淡黄而暗，眼胞微浮，容易困倦，平素舌体胖大，舌苔白腻，口粘腻或甜，身重不爽，脉滑，喜食肥甘甜粘，大便正常或不实，小便不多或微混。③心理特征：性格偏温和稳重恭谦、和达、多善于忍耐。④发病倾向：易患消渴、中风、胸痹等病证。⑤对外界环境适应能力：对梅雨季节及湿环境适应能力差。

(3) 成因。先天遗传，或后天过食肥甘。

4.5.2　文献依据

(1) 古代文献依据。①命名依据。《内经》中有“肥人”、“肥贵人”、“脂人”之说，即指体内痰湿较盛之质。②特征表述依据。《格致余论》：“肥人多痰”、“肥人湿多”；《丹溪治法心要》：“肥白人多痰湿”；《张聿青医案》：“第体丰者多湿多痰”。③发病倾向依据。《素问·奇病论》：“肥者令人内热，甘者令人中满，其气上溢，传为消渴。”《素问·通评虚实论》：“消瘅仆击，偏枯痿厥，甘肥贵人则膏粱之疾也”。④形成因素依据。《素问·奇病论》：“此肥美之所发也，此人必数食甘美而多肥也。”

(2) 现代文献依据。体型肥胖 8；或素肥今瘦 2；肤色白滑 2；鼻头微黑 1；皮肤偏白 1；或偏萎黄 1；多油腻 1；淡黄而暗 1；面色晦滞 1；面色淡 1；面色多晦黄或白 1；见目胞下鲜明 2；色微黑 1；目黄 1；精神不爽 2；精神不振、神情偏困顿、呆惰 1；肢体不爽 3；身重 7；关节疼痛重着 1；肌肤麻木不仁 1；眩晕 2；目昏 1；脘腹胀满 3；胸闷、胸脘痞闷 3；易恶心 2；睡眠多 1；痰多 3；带多、带滞淋漓而难愈 3；困倦 2；头重 2；肢节痛 1；喘 1；目多眵 1；口唇眼胞多虚浮 1；口粘腻或甜 5；口干不欲饮 4；恣肥甘 3；嗜酒茶 2；纳呆食少 4；大便正常或不实 4；大便溏泻或感觉滞涩不畅 1；大便多清稀 1；小便微浑 3；对湿环境不能适应 1；性格急躁或偏静，似无特异 2；性格偏温和稳重恭谦、和达、多善于忍耐 1。

4.6　湿热质

4.6.1　内涵

(1) 定义。以湿热内蕴为主要特征的体质状态。

(2) 体质特征。①形体特征：形体偏胖或苍瘦。②常见表现：主项：平素面垢油光，易生痤疮粉刺，舌质偏红，苔黄腻，容易口苦口干，身重困倦。副项。体偏胖或苍瘦，心烦懈怠，眼睛红赤，大便燥结，或粘滞，小便短赤，男易阴囊潮湿，女易带下增多，脉象多见滑数。③心理特征：性格多急躁易怒。④发病倾向：易患疮疖、黄疸、火热等病证。⑤对外界环境适应能力：对湿环境或气温偏高，尤其夏末秋初，湿热交蒸气候较难适应。

(3) 成因。先天禀赋，或久居湿地、善食肥甘，或长期饮酒，火热内蕴。

4.6.2　文献依据

(1) 古代文献依据。①命名依据。清·周学海《读医随笔》“素禀湿热”，《伤寒论》“酒客”。②特征表述依据。石寿棠《医原》：“若其人苍赤而瘦，肌肉坚实，素有湿热，肝热伐木火之质其体属阳。”③发病倾向依据。《素问·生气通天论》：“膏粱之变，足生大疔。”即常食膏粱厚味，以至湿热内蕴，从而易患疔疮之病。《素问·六元正纪大论》：“四之气，溽暑湿热相薄，……民病黄疸而为腑肿。”清·周学海《读医随笔》：“夫病痉者，其人必平日湿重而气滞，或血燥而气涩也。”④形成因素依据。清·叶天士《温热论》：“有酒客里热素盛，外邪入里，里湿为合。在阳旺之躯，胃湿恒多；在阴盛之体，脾湿亦不少，然其化热则一”；“吾吴湿邪害人最广”。

(2) 现代文献依据。体肥 3；肥胖或素肥今瘦 1；精神不爽 1；心烦 1；鼻孔微干 2；心烦 1；懈怠 2；怕热 1；胸闷 1；痰多 1；带多 1；身重 2；困倦 2；头重 2；纳呆 1；痰黄稠 1；带腥臭 1；而多卧 1；手足热 1；肤色偏黄 2；面色铜红 1；面垢油光 2；易生痤疮粉刺 2；鼻有油

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

泽 2;眼睛红赤 1;或见面色晦暗 1;口苦 2;口粘腻或甜 1;不耐热 3;性格多急躁易怒 3;性格做事好强、好动、志大虚说、勇敢激昂 1;多善食肥甘厚味炙烤 2;大便燥结 2;大便粘滞 1;小便短赤 3;舌质干红 1;舌红体胖 1;质偏红 1;舌苔黄腻 2;舌苔或见腻象 1;脉象正常 1;或见缓象 1;脉多见滑数 3。

4.7 瘀血质

4.7.1 内涵

(1) 定义。瘀血质是指体内有血液运行不畅的潜在倾向或瘀血内阻的病理基础,并表现出一系列外在征象的体质状态。

(2) 体质特征。①形体特征:瘦人居多。②常见表现:主项:平素面色晦暗,皮肤偏暗或色素沉著,容易出现瘀斑、易患疼痛,口唇暗淡或紫,舌质暗有点、片状瘀斑,舌下静脉曲张,脉象细涩或结代。副项:眼眶暗黑,鼻部暗滞,发易脱落,肌肤干,女性多见痛经、闭经、或经血中多凝血块、或经色紫黑有块、崩漏、或有出血倾向、吐血。③心理特征:性格心情易烦,急躁健忘。④发病倾向:易患出血、癥瘕、中风、胸痹等病。⑤对外界环境适应能力:不耐受风邪、寒邪。

(3) 成因。先天禀赋,或后天损伤,忧郁气滞,久病入络。

4.7.2 文献依据

(1) 古代文献依据。①命名依据。《内经》中称"素有恶血在内",《伤寒论》称"本有久瘀血"。《读医随笔》:"盖尊荣肥盛,是素本气虚血滞之质。"②特征表述依据。《灵枢·逆顺肥瘦》云:"广肩腋项,肉薄厚皮而黑色,唇临临然,其血黑以浊,其气涩以迟。"《灵枢·通天》:"太阴之人,多阴而无阳,其阴血浊,其卫气涩。"皆指出该型之人有气血凝滞,瘀浊不畅的特点。《伤寒论》:"所以然者,本有久瘀血,故令喜忘。"《景岳全书》:"禀有阴阳,则或以阴脏喜温暖,……有血实不易涩,有血虚不易泄,……此因人人之不同也。"③发病倾向依据。刘河间:"盖人之肥瘦,由血气虚实使然也……故血实气虚则肥……或言肥人多中风,由气虚非也。所谓腠理致密而多郁滞,气血难以通利,若阳热又甚而郁结,故卒中也。"《古今医鉴》:"心痹痛者……素有顽疾瘀血",言血瘀质为中风,胸痹发病基础。瘀血质多病出血,常逢季节而发,唐容川《血证论》中说:"乃人身气血先有偏盛,故感天气之偏盛而病遂作焉";"凡物有根者,逢时必发,失血何根,瘀血即其根也。"④形成因素依据。1) 跌扑损伤:《灵枢·贼风》云:"若有所堕落,恶血在内而不去。"《医述》引罗赤诚语:"亦有跌扑闪挫,当时不觉,至于气衰之际,不时举发。"《先哲医话》亦曰:"打扑伤横,瘀血不去,历年后卒然气短,……或妄语或健忘者是瘀血作风状。"《临证指南医案》:"其人素有瘀伤宿血",《柳宝诒医案》:"平时有瘀血在络"。2) 七情内伤:孙一奎:"死血作痛,瘦人多怒者常患此。"3) 久病入络:《素问·痹论》曰:"久病入深,营卫之行涩,经络时疏,故不通。"叶天士明确提出"久病入络",《临证指南医案》谓:"经年宿病,病必在络……因久延,体质气馁……气阻血瘀。"尚有论其经年累月之痹病、疟母、胃痛、胁痛皆为"久恙入络"。4) 年老致瘀:《灵枢·天年》:"六十岁……气血懈惰。"徐灵胎谓:"盖老年气血不甚流利",周学海《读医随笔》指出老年"食后便卧及终日稳坐,皆能凝结气血"。

(2) 现代文献依据。形体胖瘦不一 1;瘦人居多 2;发易脱落 2;精神一般 1;鼻部暗滞 1;神情或见烦躁 1;肢体伴有疼痛时,可见红斑结点 1;常感身体多处出现刺痛 1;胸、胁、少腹或肢体等处刺痛,固定不移 1;痞闷作胀 1;或见胀闷 1;肢体四肢麻木 1;全身或局部烦热感 1;局部组织硬度增强 1;或腹内有癥瘕积块 1;脏器损坏或顽固性肿大 1;女性多见痛经 2;闭经 2;或经血中多凝血块 1;或经色紫黑有块 1;崩漏 1;或有出血倾向 1;吐血 1;睡眠较差、常有失眠 1;惊悸,常易惊恐,心神不宁 1;汗毛脱落 1;肤色偏暗滞、晦滞,平素皮肤晦滞 5;或有色素沉着 1;肢体可见青紫,瘀点瘀斑,出血斑点,爪甲青紫或见红点、斑痕 3;刺痛 1;或肌肤甲错 4;皮肤干燥不容、干枯皴裂 2;或脱屑 1;青筋暴露 1;指趾末端及局部肌肉、可呈紫蓝色改变 1;面色晦滞或有色素沉着 1;面色暗 1;面色黧黑 2;或面颊部见红丝赤缕 2;口唇暗淡或紫、口唇色暗口唇紫暗、青紫 8;眼眶暗黑、紫黑 5;白珠见青丝 2;红筋浮起 1;在红筋末点有瘀点形如针尖大小 1;口干,但欲漱口不欲咽 2;便黑 1;肢体对热耐受 1;性格易急躁 2;无特异 3 或有古怪 1;舌质青紫或黑 1;或舌边青 1;有点状或片状瘀点 4;舌下静脉曲张 2;舌暗、紫暗 6;舌质可呈紫蓝色改变 1;脉象弦 2;或沉 2;涩、细涩 5;或结代 4;或弦紧 1;脉正常或见实象 1;脉弱 1。

4.8 气郁质

4.8.1 内涵

(1) 定义。由于长期情志不畅、气机郁滞而形成的以性格内向不稳定、忧郁脆弱、敏感多疑为主要表

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

现的体质状态。

(2) 体质特征。①形体特征：形体瘦者为多。②常见表现：主项：性格内向不稳定、忧郁脆弱、敏感多疑，对精神刺激适应能力较差，平素忧郁面貌，神情多烦闷不乐。副项。胸胁胀满，或走窜疼痛，多伴善太息，或嗳气呃逆，或咽间有异物感，或乳房胀痛，睡眠较差，食欲减退，惊悸怔忡，健忘，痰多，大便多干，小便正常，舌淡红，苔薄白，脉象弦细。③心理特征：性格内向不稳定、忧郁脆弱、敏感多疑。④发病倾向：易患郁症、脏躁、百合病、不寐、梅核气、惊恐等病证。⑤对外界环境适应能力：对精神刺激适应能力较差；不喜欢阴雨天气。

(3) 成因。先天遗传，或因精神刺激，暴受惊恐，所欲不遂，忧郁思虑等。

4.8.2　文献依据

(1) 古代文献依据。①命名依据。《内经》称"易伤以忧"。②特征表述依据。明·虞抟《医学正传》谓："或因怒气伤肝，或因惊气入胆，母能令子虚，因而心血不足，又或遇事繁冗，思想无穷，则心君亦为之不宁，故神明不安而惊悸怔忡作矣。"明·龚廷贤《寿世保元》云："此由思虑过度，伤于心则血耗散，神不守舍，……则卒然而忘也。"③发病倾向依据。宋·陈无择《三因极一病证方论》云："喜怒忧思悲恐惊忤郁不行，遂聚涎饮"，清·吴谦《医宗金鉴》谓："七情过节，七气生病，郁结生痰"，其在论述百合病时指出"平素多思不断，情志不遂"。④形成因素依据。体形与脏腑的大小坚脆等禀赋不同，影响气郁体质形成。如《灵枢·本藏》云："色赤小理者心小"，"心小则安，邪不能伤，易伤以忧"，"五脏皆小者，少病，苦燋心，大愁忧。"《灵枢·寿夭刚柔》云："惊恐忿怒伤气，气伤脏，乃病脏"，《素问·举痛论》："惊则心无所倚，神无所归，虑无所定"。气郁禀赋体质易因情志致病，明代·张景岳《景岳全书》："此多以衣食之累，利害之牵，及悲忧惊恐而致郁者总皆受郁之类。神志不振，……凡此之辈。"清·张璐《张氏医通》：云"郁症多缘于志虑不伸，而气受病"，"思想无穷，所愿不得，皆能致病"。

(2) 现代文献依据。精神多抑郁不爽 1；神情多烦闷不乐 2；形体多无特殊，胸胁胀满 2；痞闷作胀 1；脘腹胀满 1；食后常感胀满不适 1；头痛 1；胸闷胀痛 1；走窜疼痛 3；胃脘胀痛 1；腹痛肠鸣 1；刺痛拒按 1；妇女可见月经闭止 1；痛经 1；乳房胀痛等 2；少腹胀痛 1；痞闷作胀 1；兼见痞块 1；常感胸胁痞闷不适 1；胸闷不舒 1；善太息 1；呕吐 1；泛吐酸水 1；嗳气 2；呃逆 3；矢气 1；喘促 1；咳逆 1；或气上冲逆 1；眩晕 1；昏仆 1；出鼻血 1；或颈项瘿瘤 1；食道异物感、紧缩感 2；吞咽困难 1；睡眠较差 2；食欲减退 2。

4.9　特禀质

4.9.1　内涵

(1) 定义。表现为一种特异性体质，多指由于先天性和遗传因素造成的一种体质缺陷，包括先天性、遗传性的生理缺陷，先天性、遗传性疾病，过敏反应，原发性免疫缺陷等。其中对过敏体质概念的表述是：在禀赋遗传的基础上形成的一种特异体质，在外界因子的作用下，生理机能和自我调适力低下，反应性增强，其敏感倾向表现为对不同过敏原的亲和性和反应性呈现个体体质的差异性和家族聚集的倾向性。

(2) 体质特征。①形体特征：无特殊，或有畸形，或有先天生理缺陷。②常见表现：遗传性疾病有垂直遗传，先天性、家族性特征；胎传性疾病为母体影响胎儿个体生长发育及相关疾病特征。③心理特征：因禀质特异情况而不同。④发病倾向：过敏体质者易药物过敏，易患花粉症等；遗传疾病如血友病，先天愚型等；胎传疾病如"五迟"、"五软"、"解颅"、胎寒、胎热、胎赤、胎惊、胎肥、胎痫、胎弱等。⑤对外界环境适应能力：适应能力差，如过敏体质者对过敏季节适应能力差，易引发宿疾。

(3) 成因。先天因素、遗传因素，或环境因素、药物因素等。

4.9.2　文献依据

(1) 古代文献依据。①命名依据。古代文献称"禀赋"、"禀性"、"资禀"、"质禀"、"胎禀"，即个人生长发育状况禀受于父母。《灵枢·天年》："人之始生，以母为基，以父为楯……。"宋·刘榵《幼幼新书》引《经济经》指出："禀赋也，体有刚柔，脉有强弱，气有多寡，血有盛衰，皆一定而不易也。"《景岳全书》："以之禀赋言，则先天强厚者多寿，后天薄弱者多夭。"又云："凡小儿之病，本不易察，但其为病之源，多有所因。……虽父母之气俱有所禀，但母气之应在近，父气之应在远，或以一强一弱而偏得一人之气者，是皆不可不察。"其父母体质遗传方面可影响下一代，如《寿养丛书·褚氏遗书》中说："凡子形肖父母者，以其精血尝子，父母之身无所不历。"《幼科类粹》首篇还专论"小儿受胎禀赋厚薄不同"。《幼科发挥》提出："肥瘦，长短，大小妍丑皆肖父母。"并提出"胎痃"一词。②特征表述依据。如过敏体质《诸病源候论·漆疮候》："漆有毒，人有禀性畏漆，但见漆便中其

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

毒。”“人无问男女大小，有禀不耐漆者，见漆及新漆器，便著漆毒。”③发病倾向依据。《备急千金要方·房中补益》：“令女得病，有子必癫、痴、顽愚、㖞、哑、聋愦、挛、跛、盲、眇……多病短寿。”《医宗金鉴·幼科心法要诀》：“小儿五迟之证，多因父母气血虚弱，先天有亏，致儿生下筋骨软弱，行步艰难，齿不速长，坐不能稳，要皆肾气不足之故。”④形成因素依据。《素问·奇病论》：“人生而有巅疾者，病名曰何？……岐伯曰：病名为胎病，此得之母腹中时，其母有所大惊，气上而不下，精气并居，故令子发为巅疾也。”《诸病源候论·小儿杂病诸候》：“小儿在胎时，其母将养取冷过度，冷气入胞，伤儿肠胃。故儿生之后，冷气犹在肠胃之间。其状，儿肠胃冷，不能消乳哺，或腹胀，或时谷利，令儿颜色素㖞时啼者，是胎寒故也。”《幼科发挥》：“有因父母禀受所生者，胎弱是也，胎弱者，禀受于气不足。”

（2）现代文献依据。现代中医体质研究文献中无特征表述。

5 结语

9 种中医体质分类，是 20 多年来经文献研究、流行病学调查分析、临床观察等研究方法相结合得出的较为合理的一种假说，其理论模型将进一步通过大样本流调和临床验证，调整完善。希望通过对 9 种中医体质分类的分析与探讨，推动中医体质学的深入发展。

参 考 文 献

1 王 琦．中医体质学．北京：中国医药科技出版社，1995.70～74，78，81

2 庞万敏．眼病体质刍议．辽宁中医杂志，1985，9（7）：13

3 秦德平．浅谈气质及其与辨证施治的关系．广西中医药，1984，7（2）：6

4 匡调元．中医病理研究．上海：上海科技出版社，1980

5 何裕民．从体质调研结果探讨因时因地制宜治则．中医杂志，1986，27（5）：47

6 母国成．中医体质学说及其异化．新中医，1983，15（9）：1

7 田代华．论体质与证候．山东中医学院学报，1983，7（1）：7

8 王前奔，王前飞．中医体质的现代研究．云南中医杂志，1993，14（4）：1～3

9 何裕民，王 莉，石凤亭．体质的聚类研究．中国中医基础医学杂志，1996，2（5）：7～9

10 苏树蓉，钱柏松，黎 欣．1 061 例小儿体质调查及其体质分类的研究．中医杂志，1996，37（10）：613～616

11 朱秉臣．1 075 例老年人体型与体质关系的分析．湖南中医杂志，1998，3（5）：5

12 王 莉．男女体质特点及其异同的研究．中国中医基础医学杂志，1998，4（2）：7

13 朱 钦，郑连斌，王巧玲．回族成人的 Heath —Cartw 法体型研究．解剖学杂志，1997，（6）：27

14 张 敏，戴晓勇，刘 瑶，等．1 765 例社区人员中医体质筛查分析．河南中医，2002，4（22）：71～72

（收稿日期：2004-11-12）

Classification and diagnosis basis of nine basic constitutions in Chinese medicine

Wang Qi（王 琦）

（Beijing University of Traditional Chinese Medicine，Beijing 100029）

Abstract：Constitutional classification is the basis and core of constitutional research of Chinese medicine，which is formed through drawing the related laws from complicated constitutional manifestations and then set up a grouping system．The paper perfected the constitutional classification system，divided the human constitutions into nine basic groups．The grouping and naming basis，constitutional stating principle and method，connotation and document basis of different constitutional groups were explained respectively．

Key Words：constitutional science of Chinese medicine；study on constitutional classification；diagnosis basis

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net